2.**糖皮质激素**

①5-ASA 疗效不佳、或**重度 UC**（腹泻≥**6** 次/天等 666）**首选**　不能突然停药,会有反跳现象

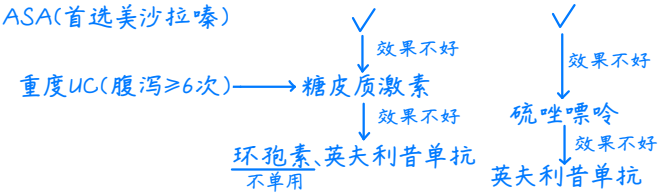
②只用于活动期诱导缓解，**不用于缓解期维持治疗**，因此症状控制后逐渐减量至停药，不宜长期使用；激素减量期间加用其它药物维持治疗　副作用大

③活动期口服**泼尼松**，重度者可先静注氢化可的松或甲泼尼龙，若无效可静注英夫利昔单抗或环孢素补救治疗

3.免疫抑制剂

①主要用于上述不佳的缓解期维持治疗，不单独用于活动期诱导缓解（起效慢）活动期诱导缓解　缓解期维持治疗

②常用**硫唑嘌呤**、巯嘌呤，不耐受者用甲氨蝶呤　轻中度UC　ASA(首选美沙拉嗪)



4.生物制剂和口服小分子药物

①在活动期诱导缓解和缓解期维持治疗均有较好疗效

②常用：

英夫利昔单抗、阿达木单抗	抗 TNF 肿瘤坏死因子
维得利珠单抗	抗整合素：阻断淋巴细胞向肠道炎症部位迁移　整合素:白细胞粘附
乌司奴单抗	抗 IL
口服小分子药物如乌帕替尼	非受体型酪氨酸蛋白激酶 JAK 抑制剂　剑圣TP:JAK、SRC、TEC、ZAP

活动期用什么诱导缓解,缓解期就用什么长期维持,注意糖皮质激素不能长期维持

（二）克罗恩病的治疗

1.活动期诱导缓解

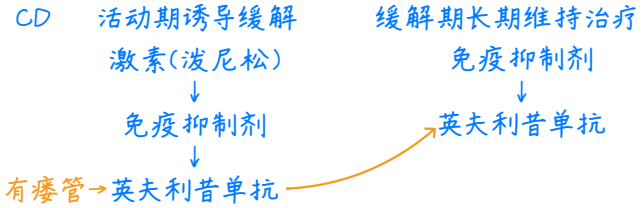
（1）**糖皮质激素**　5-ASA(对CD疗效差,不用)→糖皮质激素(长期用副作用大,缓解期维持治疗不用)→免疫抑制剂→生物制剂

①常用**泼尼松**；若病变局限在回肠末端、回盲部或升结肠的轻、中度者可用**局部发挥作用的布地奈德**（局布）

②**肛瘘慎用激素**（不利于瘘管闭合）糖皮质激素促进肝外蛋白质分解(主),肝内蛋白质合成

注意：肛瘘应内科（如**英夫利昔单抗**应付利息）+手术治疗（从内科穿到外科去了）

（2）免疫抑制剂、生物制剂和口服小分子药物



2.缓解期维持治疗

①常用免疫抑制剂

②若活动期用生物制剂或口服小分子药物诱导缓解、通常用同种药物维持治疗

专题串联 • 肠结核 VS 克罗恩病 VS 溃疡性结肠炎

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

	肠结核溃疡型	克罗恩病	溃疡性结肠炎
好发年龄	青壮年		
慢性发热	低热多见	不发热或低热多见	不发热或低热多见
体重下降	可有		
慢性腹痛	多为**右下**腹 （好发**回盲部**）	多为**右下**腹 （好发**回肠末端及邻近结肠**）	多为**左下**腹 （好发**直肠及乙状结肠**）
脓血便和里急后重	多无	多无 若累及左边即可有	多**有**